SDD 136 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatrie

Date : 08/12/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble - ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES Médecine interne Paris - ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Aucun
Item(s) en lien avec la station	ITEM 66 - Trouble obsessionnel et compulsif
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 136 Trouble obsessionnel, comportement compulsif
Matériel nécessaire à la station	Un bureau et 2 chaises
Contexte de la station	Patient envoyé voir son médecin généraliste par le pharmacien

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e interne en médecine générale et vous recevez monsieur Djaltz, 35 ans, qui vient vous voir sur conseil de son pharmacien, pour un comportement qui serait évocateur de trouble obsessionnel et compulsif. En effet, le patient aurait lavé frénétiquement les boîtes de médicaments devant le pharmacien, expliquant ne pas vouloir être contaminé.
Vous vous apprêtez à interroger ce patient qui n'a pas d'antécédent personnel ni familial, ni traitement.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :
- Interroger le patient
- Décider de l'orientation du patient face au trouble présenté

Vous ne devez pas :
- Faire un examen clinique
- Prescrire un traitement
- Recherche un autre syndrome psychiatrique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Demande le contenu des pensées obsessionnelles	1 pt	☐
2.	Demander si ces idées sont ressenties comme intrusives pour le patient	1pt	☐
3.	Demander si les pensées obsessionnelles sont sources d'angoisse	1 pt	☐
4.	Demande ce que le patient met en place pour soulager l'angoisse de ces obsessions	1 pt	☐
5.	Demande la durée moyenne par jour des compulsions/ obsessions	1 pt	☐
6.	Recherche un impact de ces symptômes sur au moins 2 des 3 domaines suivants : ● Professionnel ● Social ● Loisir	1 pt	☐
7.	Recherche une souffrance importante en lien avec ces symptômes	1 pt	☐
8.	Recherche un évitement des situations qui déclenchent potentiellement ces symptômes	1 pt	☐
9.	Recherche si le patient trouve ces comportements (compulsions) cohérents ou logiques ou inappropriés	1 pt	☐
10.	Recherche si le patient trouve ces pensées de contamination (obsessions) cohérents ou logiques ou inappropriés	1 pt	☐
11.	Recherche depuis combien de temps ces symptômes sont présents	1 pt	☐
12.	Rechercher une prise de toxique (au moins 2 sur les 3 suivants) : alcool, cannabis, drogue	1 pt	☐
13.	Orientation vers un psychiatre ET/OU un psychologue	1 pt	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			

1.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.	**2. APTITUDE À QUESTIONNER**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3.	**4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

4.	**5. COMMUNICATION NON VERBALE**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL (max 20 items)	**…/ 16 points**

Éléments de rétroaction :

Le diagnostic de TOC ne nécessite que la présence d'obsession (pas besoin de compulsion forcément), mais il faut quand même rechercher des compulsions. Une fois ces symptômes mis en évidences, il faut pour le diagnostic rechercher :

- *La durée par jour (au moins d'une heure)*
- *L'impact sur une dimension de la vie du patient (sociale, professionnelle…) OU une souffrance cliniquement significative (on va donc rechercher les 2)*
- *La présence d'un "insight" (si le patient à conscience de l'absence de réel fondement de ces obsessions/compulsions)*
- *Des diagnostics différentiels possible : Recherche de toxique, recherche d'autres pathologie psychiatrique*
- *La durée de ces symptômes (ATTENTION, même si le diagnostic de TOC ne nécessite pas de savoir depuis combien de temps sont présent les TOC, il reste intéressant de savoir depuis combien de temps ils sont installés)*

Le sujet ici vous demande de ne pas rechercher d'autres pathologies psychiatriques (donc pas de syndrome dépressif en lien avec cela), mais la souffrance en lien avec le trouble est quand même à rechercher. Qui plus est, élément très important, il FAUT rechercher des prises de toxiques !!!

Concernant leur prise en charge ON ORIENTE VERS PSYCHIATRE/PSYCHOLOGUE car les TOCs nécessitent en 1ère intention de la TCC +++. Pour l'externat, vous n'avez pas à apprendre les 1ère/2nd intention du TOC. Ainsi, une orientation vers un psychiatre ne vous sera pas pénalisée dans tous les cas.

Dans le reste de la prise en charge, on note :
- Rencontre des proches et explication de la pathologie à ces derniers pour qu'ils ne participent pas aux rituels et ne les entretiennent pas (avec l'accord du patient bien sûr → Secret professionnel)
- Antidépresseur avec une information et un usage différents par rapport aux trouble anxio-dépressif :

- *Dosage souvent très supérieur*
- *Temps de latence avant efficacité plus long (6 à 12 semaines)*

Commenté [1]: Les traitements?

Commenté [2]: J'ai regardé le cours et dessus on précise pas les degré d'intention. Hors les degré d'intention dépende de la gravité du TOC (ce qu'ils n'ont pas a apprendre)

Commenté [3]: En soi c'est comme pour le TDAH : 1ère intention = psychothérapie, 2nd intention = méthylphénidate

Commenté [4]: Je corrige, pour les TOC, ils ont juste à connaître que traitement possible = Psychiothérapie TCC et ISRS

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes un.e médecin généraliste et vous recevez monsieur Djaltz, 35ans, qui vient vous voir sur conseil de son pharmacien, pour un comportement qui serait évocateur de Trouble obsessionnel et compulsif. En effet, le patient aurait lavé frénétiquement les boîtes de médicaments devant le pharmacien, expliquant ne pas vouloir être contaminé.
Vous vous apprêtez à interroger ce patient qui n'a pas d'antécédent personnel ni familial, ni traitement

Plan de la station ECOS :

Patient.e simulé.e et candidat.e assis de part et d'autre de d'un bureau sur des chaises.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

" Bonjour Docteur. mon pharmacien m'envoie ici soit disant parce que j'aurais un TOC, il m'a conseillé de venir vous voir pour que vous me posiez des questions"

Identité du patient :

Mr. Djaltz, 35 ans, Homme
1m80, 80kg

Mode de vie :

Chômeur, pas d'activité sportive depuis 4 mois (auparavant tennis)

Divorcé, un enfant en garde alterné
Pas de tabac, pas d'alcool, pas de toxique (pas cannabis, ni autre drogue)

Comportement global :

Troublé, stressé, honteux de parler de ces symptômes

Antécédents personnels :

Pas d'antécédent personnel

Antécédents familiaux :

Pas d'antécédent familiaux

Médicaments :

Pas de traitement

Symptômes positifs :

- Quand l'on vous demande ce qui fait pensez à un TOC "Selon le pharmacien, j'ai lavé de façon importante avec du gel hydro-alcoolique les médicaments qu'il m'a fourni. Il m'a demandé pourquoi et j'ai expliqué que je ne voulais pas être contaminé"
- Quand l'on vous demande par quoi vous avez peur d'être contaminé "Il y a des bactéries partout de nous jours. Regardez le Covid"
- Si vous dit que le Covid est un virus : "Ah oui pardon c'est un abus de langage de ma part"
- Quand l'on vous demande combien de temps vous passez à penser au risque de vous contaminer : "Quasiment tout le temps quand je suis en dehors de chez moi"
- Quand l'on vous demande combien de temps vous passez à laver les affaires : "plusieurs heures par jour : je le fais avant de les toucher et avant de les rentrer dans ma maison"
- Quand l'on vous demande depuis combien de temps vous avez ces pensées et comportements : "Euh je lave depuis au moins 4 mois"
- Quand l'on vous demande s'il y a un événement qui a déclenché ces comportements : "Non j'en avais juste marre de souvent tomber malade"
- Quand l'on vous demande si il éprouve une détresse/une angoisse/ une souffrance vis-à-vis de ces pensées ou comportements : "Eh bien je vous avoue

me sentir souvent tendu et souvent fatigué à cause de cela…”
- Si l’on vous demande si vous trouvez ces idées comme intrusives/ non contrôlées : “Eh bien elles surgissent un peu sans crier gare pour tout contexte dès que je suis dehors, ou même parfois chez moi quand un objet pourrait être possiblement contaminé par des germes”.
- Quand l’on vous demande si ces éléments ont eu un impact sur votre vie professionnelle : “eh bien j’ai perdu mon travail dans les transports scolaires car j’arrivais souvent en retard, je nettoyais beaucoup les choses que je touchais, créant des retard donc oui…”
- Quand l’on vous demande si ces éléments ont eu un impact sur votre vie sociale : “Je ne vois presque plus personne depuis, je communique par téléphone avec les gens pour éviter de sortir et de me contaminer”
- Quand l’on vous demande si ces éléments ont un impact sur vos loisirs : “J’ai arrêté le sport depuis 4 mois pour tout vous dire…”
- Si l’on vous demande ce que vous faites pour calmer l’angoisse liés aux pensées de contamination : “ Eh bien les lavages que je fais calment mon anxiété”.
- Si l’on vous demande ce que vous pensez de vos comportements (s’ils sont logiques/inappropriées) : “Ah bah ils m’handicapent énorméments dans la vie vu que je passe beaucoup de temps à les faire, mais si je ne le fais pas impossible de me sentir serein”
- Si l’on vous demande ce que vous pensez de ces pensées de contamination (si elles sont logiques/inappropriées): “Je vous avoue que en soi je ne pense pas que je vais forcément être contaminé, mais je suis angoissé par cela… et ça me pousse pour me calmer à laver”.
- Quand l’on vous demande si vous prenez alcool/drogue/cannabis : “Non pas du tout”
- Quand l’on vous demande si vous évitez de faire des choses ou des situations à causes de ces idées de contaminations ou à cause de ces lavages : “Eh bien j’évite de sortir hormis quand cela est nécessaire”
- Quand vous demande ce que vous alliez chercher en pharmacie : “De la Gelée royale pas des médicaments”

Questions de relance :

- Si n’a pas dit vers qui il vous oriente, demandez à 6min30 : “Qui va pouvoir m’aider ?”

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patient.e simulé.e et candidat.e assis de part et d'autre de d'un bureau sur des chaises.

Matériel nécessaire à la station :

- *Feuille de papier sur la table*
- *Un crayon*
- *2 chaises*
- *Une table*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*